검진 뇌동맥류 초회 의뢰 · 추적 · 응급 평가

크기 하나로 결정하지 않고 위치·형태·증상·환자 요인을 함께 확인

첫 발견과 추적 중 변화를 구분

검진에서 동맥류 발견
판독·이전 영상·증상 확인

무증상 첫 발견
신경외과 외래 위험 평가
저위험이면 정기 추적

급성 안검하수 · 복시
동공 산대 동반 시
곧바로 응급실 이송

초회 상담 · 인계 항목

- ☐ 판독명·검사일·이전 영상: _____
- ☐ 크기 ___ mm · 위치 _____ · 불규칙성/daughter sac _____
- ☐ 증상·나이·과거 SAH·가족력·ADPKD/결합조직질환 _____
- ☐ 혈압·흡연·항혈전제·이전 치료/스텐트 여부 _____

증상 분기
급성 안검하수·복시에서 동공 크기와 대광반사를 확인합니다. 강의는 당뇨병성 마비의 동공 보존과 동맥류 압박의 동공 침범을 비교했습니다.

관찰·재의뢰·응급을 나누는 기준

상황	다음 단계
처음 발견된 무증상 병변	**박중철 연자 Q&A:** 신경외과 외래에서 위험도를 먼저 평가하고 저위험이면 검진센터 추적 가능
관찰 중 안정적 소형 병변	발견 후 첫 MRA **6~12개월**, 안정적이면 이후 **1~2년** 간격
1~2 mm 이상 성장 또는 새로운 돌출·불규칙성	즉시 신경외과로 연결해 치료 여부 재평가
갑작스러운 안검하수·복시, 특히 동공 산대·대광반사 저하	동맥류성 제3뇌신경마비 감별 → **응급실 이송**

추적 인계 기록

확인·설명	계획
신경외과 위험 평가 결과 _____	추적기관 _____ 다음 MRA _____
혈압·금연 계획 _____	결과 확인 담당 _____

강의의 치료 후 영상: 코일 후 6개월·18개월·3~5년, 클리핑 후 5년 내 MRA/CTA. 박중철 연자 Q&A는 관찰 중 동맥류가 있다는 이유만으로 필요한 항혈소판제·항응고제를 금기하지 않으며, 파열 시 출혈량은 늘 수 있다고 설명했습니다.

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호 · 031-893-4560
아산 28회 연수강좌 — 검진에서 발견된 뇌동맥류: 어떻게 추적하고 언제 치료할까?(박중철)

뇌동맥류 위험 평가 상세

추적과 치료 결정은 신경외과 평가 및 개별 위험–이득 판단으로 연결

크기·위치·형태를 함께 읽습니다

강의의 구분	평가 포인트
저위험 쪽	소형·전방순환·무증상·매끈한 형태. Infundibulum은 보통 **≤3 mm** 깔때기 확장과 정점 분지 혈관으로 감별
치료를 적극 검토할 단서	증상성, 성장·불규칙성, 후방순환·ACoA·PCoA, 젊은 환자의 누적 위험. 고령은 시술 위험도 함께 비교
강의에 소개된 치료 크기 기준	전방 **≥7 mm** · 후방 **≥6 mm** 치료 고려. 국내 설명에서는 **5 mm**를 치료 검토 기준으로 제시

신경 압박에 따른 뇌신경 마비 또는 극심한 국소 두통을 유발하는 증상성 동맥류는
크기와 무관하게 즉각적인 치료 대상으로 신경외과에 연결합니다.

UCAS Japan: 강의의 크기별 연간 파열률

3~4 mm	5~6 mm	7~9 mm	10~24 mm	≥25 mm
0.36%	**0.50%**	**1.69%**	**4.37%**	**33.4%**

전체 연간 파열률 0.95%. MCA 대비 HR: PCoA 1.90, ACoA 2.02; daughter sac HR 1.63. 강의는 위험이 낮은 병변의 불필요한 치료에도 영구 신경학적 합병증 1~2%가 있음을 설명했습니다.

혈압·금연과 가족 선별

내과에서 함께 관리

강의 목표 혈압 **<130/80 mmHg**. 금연 상담·니코틴 대체요법, 과음·교감신경 자극제 사용을 살핍니다. 흡연은 형성·파열 위험을 **2~3배** 높이는 인자로 설명되었습니다.

가족·질환 조건	강의의 선별 설명
ADPKD	유병률 **8~12%**, 초기 MRA. 정상이라도 약 **4~5년**마다 추적
1촌 뇌동맥류/SAH 가족 **2명 이상**	유병률 **>10%**, **20세 이상**부터 MRA 권장
Marfan · Ehlers–Danlos type IV	유전·가족력 기반 고위험 선별 고려

내시경·치료 후·약물 인계

내시경을 일괄 금기로 두지 않습니다

소형 저위험 병변은 내시경 금기가 아니며, 대형·증상성은 시술 전 협진합니다. 스텐트 보조 코일 후 DAPT는 통상 **3~6개월**; EMR·ESD와 약제 조정은 신경외과·소화기내과가 함께 결정합니다.

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호 · 031-893-4560

자료 다시 보기
QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/neurology/screening-cerebral-aneurysm-card/